2. Servicios a Ofrecer

2.1. Servicios ámbito Sanitario (asistenciales)

Con el fin de asegurar la mejora de la calidad de vida de los pacientes que ingresen al Programa de Crónicos Complejos, es necesario contar con una cartera de servicios de alto valor añadido y que dé respuesta a las necesidades de los pacientes y sus familiares desde un punto de vista integral, incluyendo con ello actividades enfocadas a satisfacer necesidades desde un punto de vista físico, psicológico, social y comunitario.

Dentro de estos, los **servicios sanitarios asistenciales**, cubrirán las necesidades clínicas de los pacientes con enfermedades crónicas complejas.

Identificar perfectamente los servicios que el prestador ofrece, será fundamental para que tanto aseguradora como prestadores y los propios beneficiarios del programa (pacientes y familiares) sepan qué queda cubierto y que no queda cubierto a través del propio programa, así como cuál es la institución encargada de ofrecer cada servicio en función de los acuerdos alcanzados entre las partes y a qué tipo de pacientes van dirigidos cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta los requisitos de la Metodología NEWCARE y las características del recurso se pueden identificar servicios en los 2 niveles asistenciales (básico y especializado) y en los 3 niveles o lugares de atención (domicilio, ambulatorio y hospital), de tal manera que se cubran todas las necesidades sanitarias de los pacientes en función de su grado de complejidad.

Así se propone identificar en cada servicio a ofrecer los procedimientos a realizar (exploración física, toma de tensión, valoración del paciente, oxigenoterapia, análisis… etc.), los profesionales que intervienen (médico especialista geriatra/medicina interna, enfermera jefe, médico familiar/general, trabajo social, subespecialistas, rehabilitador fisioterapeuta,…), el nivel asistencial (básico o especializado), Grado de complejidad (alto o medio) y lugar de atención (domicilio, consulta ambulatoria, hospital, hospital de día, servicio de urgencias…)

Ejemplos de servicios a ofrecer

- Servicio de atención directa en domicilio por cada uno de los miembros del equipo asistencial
- Servicio de atención directa en consulta ambulatoria por cada uno de los miembros del equipo asistencial
- Servicio de internamiento especializado.
- Consulta médica con historia clínica completa y plan de manejo clínico

- Seguimientos telefónicos
- Consulta prioritaria ante descompensación
- Interconsultas con especialistas ante descompensaciones y/o agudizaciones
- Atención por enfermería
- Toma de muestras
- Manejo de procedimientos instrumentales (detallar los procedimientos a realizar)
- Servicio de atención 24/7 enfermería y medicina
- Servicio de urgencias 24/7, de forma presencial.
- Servicios de recuperación de la salud (rehabilitación tras procesos quirúrgicos u otros procesos que así lo precisen)
- Servicio de transporte sanitario
- Servicios de tele monitorización
- Servicios de tele medicina o telesalud
- Servicios de rehabilitación y otras terapias
- Servicios de gestión y administración: asistencia juntas, registros, etc.
- Servicios de cuidados profesionales por auxiliar de enfermería
- Otros perfiles complementarios como psicólogo, nutricionista, fisioterapia, terapias específicas según la patología de origen, Teleasistencia, especialistas de las patologías.
- Promoción y educación en salud consulta o en visita (videos, folletos…)
- Etc.

Ejemplo de listado de procedimientos (indicar los procedimientos posibles a realizar y el ámbito

Servicios	Procedimientos
Servicio de atención directa en domicilio	Toma de Tensión Arterial y constantes ECG Pulsioxímetría Destrostix (Nivel de glucosa) Oxigenoterapia/Aerosolterapia Analítica básica: Hemograma/Bioquímica General/E. Coagulación/Orina y Sedimento Administración de fármacos por vía intravenosa o subcutánea mediante infusión subcutánea continua. Antibioterapia intravenosa Administración de fármacos (antibioterapia, analgesia, diuréticos, antitérmicos, profilaxis HBPM…)

	Sondaje Vesical Sondaje Nasogástrico Anticoagulación SC Hidratación mediante Hipodermoclisis. Ventilación Mecánica No Invasiva Manejo de Gastrostomía Manejo de Traqueostomía ¿Paracentesis Evacuadora Domiciliaria? Indicación de Procedimientos a realizar en Unidad de Día/Unidad de crónicos (Transfusiones/Toracocentesis/Nutrición Enteral…). Derivación a unidad día para procedimientos puntuales
Servicio de atención directa en Consulta Ambulatoria	Consulta programada con médico y enfermera Consulta preferente con especialista ante descompensación Toma de constantes Anamnesis completa e historia clínica Exploración por aparatos Consulta con rehabilitación Terapias puntuales programadas
Servicio de atención directa en hospital	Toma de Tensión Arterial ECG Pulsioxímetro Destrostix (Nivel de glucosa) Oxigenoterapia/Aerosolterapia Analítica básica: Hemograma/Bioquímica General/E. Coagulación/Orina y Sedimento Administración de fármacos (antibioterapia, analgesia, diuréticos, antitérmicos, profilaxis HBPM…) Sondaje Vesical Sondaje Nasogástrico Administración de fármacos por vía intravenosa o subcutánea mediante infusión subcutánea continua. Antibioterapia intravenosa Anticoagulación SC Hidratación mediante Hipodermoclisis. Ventilación Mecánica No Invasiva Manejo de Gastrostomía Manejo de Traqueostomía

	Paracentesis Evacuadora Otros Procedimientos a realizar en Unidad de Día/Unidad de crónicos: Transfusiones/Toracocentesis/Nutrición Enteral…

2.2. Servicios ámbito Social

A su vez, la Entidad deberá ofertará un mínimo de servicios sociosanitarios que garanticen la adherencia a los tratamientos propuestos en cada caso. Serán acciones que se dirigirán a satisfacer las necesidades sociales de los pacientes y de su familiar (cuidador principal).

Algunos de los servicios que se pueden ofrecer en este ámbito son:

- **Servicio de atención en actividades instrumentales** (ej. recogida de recetas médicas, compra de las mismas, manejo de dispositivos sociosanitarios instalados en el hogar, etc.).

- Servicios **de apoyo a trámites y gestiones** relacionadas con su salud.

- **Servicio de Teleasistencia domiciliaria**, para pacientes en domicilio con baja funcionalidad y alta dependencia. Sistema de atención personalizada, de respuesta inmediata ante situaciones de emergencia o inseguridad, soledad y aislamiento.

- **Servicios de ayuda a domicilio**, para pacientes que necesitan ayuda para actividades básicas de la vida diaria y no cuentan con apoyo para las mismas, provocando la no realización de estas un empeoramiento en su estado de salud. Ej. Aseo personal del paciente y de los posibles "dispositivos funcionales y/o de cuidados" tales como los dispositivos de alimentación enteral (PEG), cánulas de traqueotomía, bolsas de ostomía, cambios de sondas, etc.".

- **Servicio de apoyo psicológico y/o grupos de ayuda mutua**, tanto para el paciente como para los familiares, sobre todo los cuidadores principales en los casos en los que se detecte sobrecarga del cuidador o en cualquier otro supuesto cuando lo solicite el propio cuidador o detecte la necesidad y así lo proponga un profesional del equipo de atención.

- Servicios de **promoción/educación de la salud**. **Talleres de formación para pacientes y cuidadores.** Talleres de autocuidado para cuidadores.

- **Servicio de respiro familiar,** mediante la articulación de recursos humanos, tecnológicos, estructurales, etc. necesarios para que un paciente pueda ser durante un tiempo determinada atendido y cuidado por otras personas que no sean sus cuidadores principales.

En caso de que la Entidad ofrezca alguno de estos servicios, habrá que definir en este punto del manual a qué pacientes se dirigen, con **qué intensidad y cuáles son los profesionales que están vinculados a cada uno de ellos.**

2.3. Servicios ámbito Comunitario

Liderados por la Trabajadora Social del equipo a través de la Promoción Comunitaria, para dar una respuesta proactiva y reactiva a necesidades que puedan cubrirse mediante la implicación de la comunidad en el cuidado de las personas con IOCC con los objetivos de: aumentar la red de cuidados, reducir la sobrecarga del cuidador principal y aumentar la satisfacción de los pacientes y familiares.

Se basan en la gestión y desarrollo de redes de cuidados en los casos en los que se detecten factores sociales alterados como sobrecarga del cuidador principal, imposibilidad de realización de actividades básicas de la vida diaria, etc de tal forma que la comunidad sea un eje más de implicación y atención en el cuidado de los pacientes que forman parte del programa.

Para implicar a la comunidad, la trabajadora social realiza una valoración social a través de diferentes herramientas y escalas como son el genograma, la detección de red, la escala Gijón y la Escala Zarit, identificando los posibles focos de vulnerabilidad en la unidad familiar y activando a agentes, y/o personas con capacidad y voluntad de implicación en el cuidado de personas con IOCC.

Para desarrollar los servicios del ámbito comunitario se deben realizar las siguientes acciones:

2.3.1. **Sensibilización:** Las acciones de sensibilización van enfocadas a ampliar el conocimiento en la población sobre la atención de las personas con enfermedades crónicas avanzadas. El fin último de esta fase es realizar acciones de sensibilización a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar y acompañar a estas personas, de forma que se favorezcan tanto las redes de cuidados como el desarrollo del voluntariado. Sirven para difundir y hacer llegar a los diferentes actores de la comunidad la importancia y el valor del cuidado y acompañamiento.

2.3.2. **Formación comunitaria:** Educar y formar a la comunidad y a las personas sensibilizadas que quieran participar en el voluntariado, acerca de las enfermedades crónicas avanzadas, su gestión y acompañamiento, de forma que pueda apoyar las acciones de sensibilización, pero brinde mayor conocimiento en diferentes ámbitos como universidades, red de prestadores, grupos de cuidadores, etc.

2.3.3. **Servicio de voluntariado:** Entre los servicios comunitarios se encuentra el Servicio de voluntariado dirigido, donde personas voluntarias, pero con formación específica según tareas asignadas, podrán formar parte del cuidado de los pacientes que así lo requieran y acepten voluntariamente este tipo de cuidado. Un voluntario no es un profesional cualificado ni a nivel sanitario, ni a nivel social, por lo que, en todo caso, su actividad debe estar supervisada y pautada por un profesional socio sanitario de referencia para el paciente.

2.3.4. **Identificación y acuerdos con agentes clave:** Los agentes clave pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen interés en un proyecto, poseen información, recursos, experiencia y son considerados como aquellos que pueden influenciar o son muy importantes para que se desarrolle el proyecto. Entre los posibles tipos de agentes clave se encuentran: escuelas, institutos, centros culturales; asociaciones y comunidades religiosas, administraciones públicas, organismos oficiales, colegios oficiales, organizaciones sin ánimo de lucro (ong's), fundaciones, obras sociales, empresas y asociaciones de empresarios, agrupaciones ciudadanas, colegios profesionales…

2.3.5. **Servicio de creación de redes de cuidado**: La Entidad debe garantizar a través de la trabajadora social de la actividad un Servicio de creación de redes de cuidado: consistente en identificar las

necesidades de los pacientes que puedan ser cubiertas por redes de apoyo así como establecer contacto con agentes, entidades, personas… con capacidad y voluntad de implicación en el cuidado de personas con IOCC que permanezcan en su domicilio y no cuenten con los recursos humanos suficientes para su cuidado. Las necesidades de atención y cuidado se identificarán en los cuestionarios de la valoración multidimensional. A partir de la detección de necesidades en cada una de sus atenciones se procederá a identificar y coordinar los diferentes agentes, entidades, personas con capacidad y voluntad de implicación en el cuidado de asegurados con IOCC que permanezcan en su domicilio y no cuenten con los recursos humanos suficientes para su cuidado. Para la creación de redes se puede contar con la ciudadanía en general, a los profesionales de los centros sanitarios y sociosanitarios de la red de prestadores, universidades, entidades de tercer sector, agentes de control, etc. e irán vinculándolos con acciones de sensibilización hacia el cuidado de pacientes crónicos complejos, formación de voluntarios, formación de cuidadores, por ej. Formación a los cuidadores principales de los pacientes con insuficiencias respiratorias para realizar un buen manejo de estos en el domicilio.

Acciones a desarrollar por el promotor comunitario (Trabajador social domiciliario)

La principal función del promotor comunitario es la creación y gestión de redes de cuidados que cubran necesidades insatisfechas alrededor de las personas con enfermedad avanzada y/o al final de la vida. Para ello debe:

- Identificar aquellas necesidades socio comunitarias de las personas en final de vida que requieren una mayor carga de atención por parte de los cuidadores y el perfil de personas que las cubren.
- Detectar posibles integrantes de las redes de apoyo que puedan cubrir las necesidades detectadas y describir sus características fundamentales.
- Desarrollar intervenciones comunitarias que favorezcan la creación y gestión de las redes de apoyo a medida que avanza la enfermedad.
- Mapear las necesidades de los casos identificados de medio y alto riesgo psicosocial y activar la red comunitaria para dar respuesta a ellas.
- Cubrir las necesidades emocionales, sociales, de cuidados y acompañamiento de las personas al final de la vida y sus redes.
- Valorar de forma progresiva las intervenciones comunitarias para la mejora de la calidad de vida del paciente y sus redes.

Además, el promotor de la comunidad debe realizar entre sus funciones aquellas que se relacionan con las siguientes acciones:

- Promover/Desarrollar acciones de sensibilización social (actividades en centros, con voluntarios, con la sociedad en general, etc.).
- Promover/Desarrollar acciones formativas sobre el desarrollo de redes de cuidados y aspectos prácticos del acompañamiento (talleres para cuidadores, para profesionales, para personas con enfermedad avanzada, colaboradores, etc.).
- Promover/Desarrollar acciones de intervención dentro de la comunidad.

- Identificar e implicar a centros y recursos para atender a las necesidades de las personas con enfermedad avanzada y/o al final de la vida en las ciudades, barrios, distritos, etc. CREAR RED DE PERSONAS Y AGENTES CLAVE.
- Movilizar a la RED implicada en construir Redes de cuidados sensibilizados y capacitados para cuidar y acompañar a aquellos que sufren enfermedad crónica avanzada.
- Gestión del voluntariado